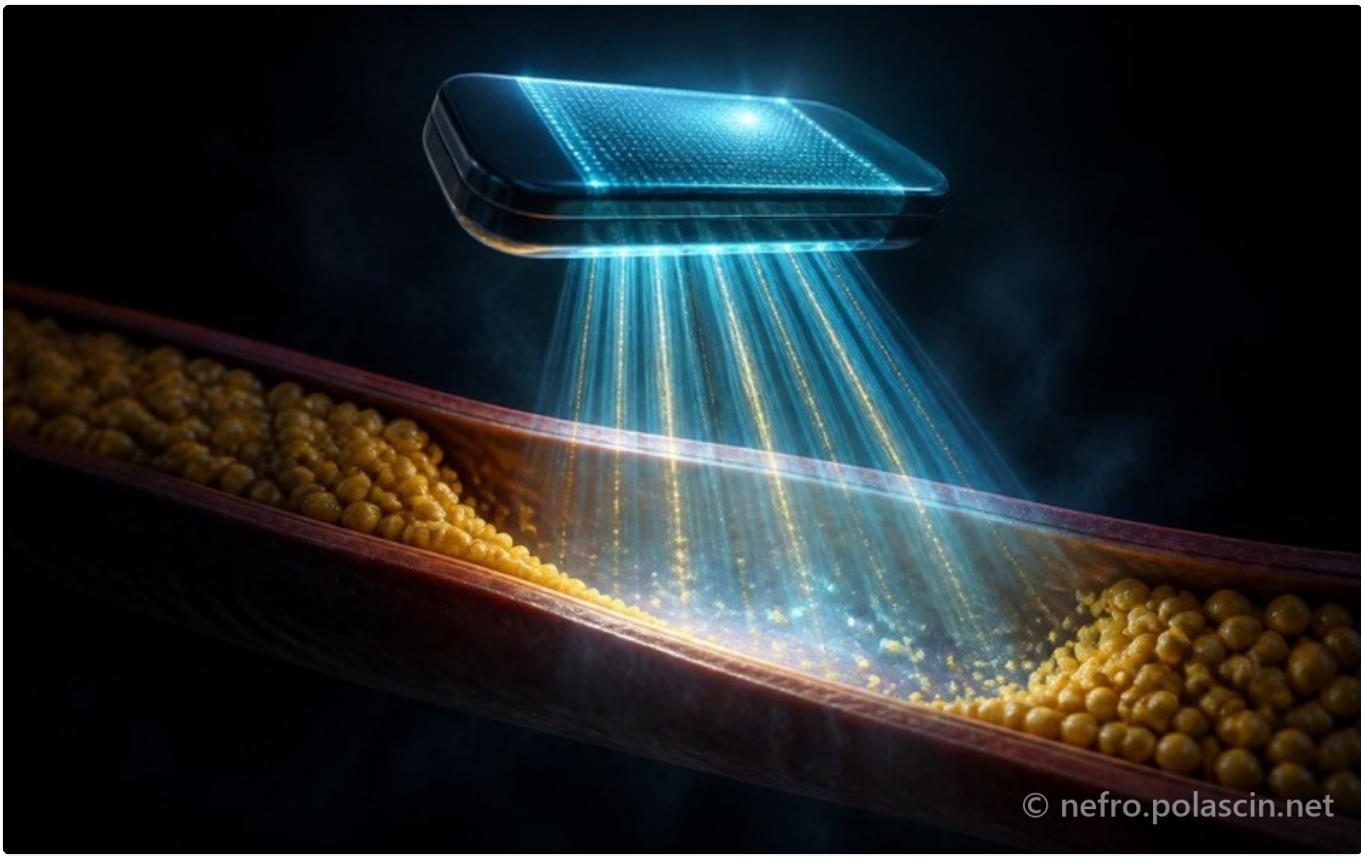
Nové odporúčania pre manažment dyslipidémie 2026: čo prinášajú do klinickej praxe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Ilustračná scéna. Odporúčanie má cenu až vtedy, keď sa premietne do konkrétneho postupu v ambulancii.

V roku 2026 boli publikované nové multisocietné odporúčania pre manažment dyslipidémie. Ide o dokument **2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Dyslipidemia**, publikovaný v časopise *Circulation*. Odporúčania sa zameriavajú na hodnotenie, liečbu a sledovanie pacientov s poruchami lipidového metabolizmu vrátane zvýšeného LDL cholesterolu, aterogénnych lipoproteínov a celkového kardiovaskulárneho rizika.

Ich hlavným cieľom je znížiť riziko aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia — infarktu myokardu, ischemickej cievnej mozgovej príhody, periférneho artériového ochorenia a ďalších komplikácií aterosklerózy.

Dyslipidémia ako rizikový faktor, nie izolované laboratórne číslo

Nové odporúčania opäť zdôrazňujú, že dyslipidémia sa nemá hodnotiť izolovane. Samotná hodnota LDL cholesterolu je dôležitá, ale rozhodovanie o liečbe má vychádzať z celkového rizikového profilu pacienta.

Do úvahy treba brať najmä:

- vek,
- pohlavie,
- krvný tlak,
- fajčenie,
- diabetes mellitus,
- chronická choroba obličiek,
- prekonané kardiovaskulárne ochorenie,
- rodinnú anamnézu predčasnej aterosklerózy,

- hodnoty LDL cholesterolu, non-HDL cholesterolu a ďalších aterogénnych častíc.

Praktický význam je jasný: neliečime iba laboratórny výsledok, ale pacienta s konkrétnym rizikom.

Dôraz na aterogénne lipoproteíny

Odporúčania sa sústreďujú na lipoproteíny, ktoré majú priamy vzťah k ateroskleróze. V centre pozornosti zostáva **LDL cholesterol**, ale väčší význam sa prikladá aj ďalším ukazovateľom, najmä **non-HDL cholesterolu**, **apoB** a **lipoproteínu(a)**.

Tento posun je klinicky dôležitý. Niektorí pacienti môžu mať prijateľnú hodnotu LDL cholesterolu, ale zvýšený počet aterogénnych častíc. Práve v takýchto prípadoch môže apoB alebo non-HDL cholesterol lepšie vystihovať skutočné riziko.

Lipoproteín(a): meranie aspoň raz v dospelosti

Jednou z výrazných noviniek je silnejšie odporúčanie merať **lipoproteín(a)**, označovaný ako Lp(a). Zvýšený Lp(a) je geneticky podmienený rizikový faktor aterosklerózy a aortálnej stenózy. Bežné režimové opatrenia ho zvyčajne významne neznižujú.

Odporúčania podporujú vyšetrenie Lp(a) najmä preto, že môže zmeniť odhad rizika a viesť k intenzívnejšej kontrole ostatných modifikovateľných rizikových faktorov.

Pre prax to znamená: u dospelého pacienta s nejasne vysokým rizikom, predčasným kardiovaskulárnym ochorením v rodine alebo osobnou anamnézou aterosklerózy napriek relatívne dobrým lipidom má Lp(a) reálnu výpovednú hodnotu.

Nový prístup k odhadu rizika

Nové odporúčania zavádzajú modernejší spôsob hodnotenia kardiovaskulárneho rizika. V americkom prostredí sa do popredia dostáva kalkulátor **PREVENT**, ktorý má lepšie odrážať súčasnú populáciu a širšie spektrum kardiometabolických rizík.

Riziková stratifikácia je dôležitá najmä v primárnej prevencii, kde pacient ešte nemal infarkt, cievnu mozgovú príhodu ani inú manifestáciu aterosklerotického ochorenia. Práve tam je rozhodovanie najcitlivejšie, pretože liečba má preventívny charakter a absolútny prínos môže byť u niektorých pacientov malý.

Návrat cieľových hodnôt LDL cholesterolu

Významnou zmenou je opätovné zdôraznenie cieľových hodnôt LDL cholesterolu. V minulosti sa v niektorých amerických odporúčaniach viac presadzovala intenzita statínovej liečby než konkrétny cieľ LDL. Novší prístup sa opäť približuje praktickému sledovaniu dosiahnutej hodnoty.

Tento prístup má výhodu: lekár aj pacient vidia, či liečba skutočne dosiahla očakávaný efekt. Zároveň umožňuje rozhodnúť, kedy pridať ďalšiu liečbu — napríklad ezetimib, inhibítor PCSK9 alebo inú hypolipidemickú terapiu.

Liečba: základom ostávajú statíny

Statíny zostávajú základom farmakologickej liečby dyslipidémie. Majú najlepšie dôkazy o znížení rizika kardiovaskulárnych príhod a mortality u vhodne vybraných pacientov.

Liečba sa má voliť podľa rizika:

- u pacientov so známym aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením je cieľom intenzívna redukcia LDL cholesterolu,
- u pacientov s veľmi vysokým rizikom môže byť potrebná kombinovaná liečba,
- u pacientov v primárnej prevencii má rozhodnutie vychádzať z individuálneho rizika a rozhovoru s pacientom,
- u pacientov s diabetom, chronickou chorobou obličiek alebo familiárnou hypercholesterolémiou treba riziko hodnotiť osobitne prísne.

Statín však nemá byť predpisovaný mechanicky. Rozhodnutie má zahŕňať očakávaný absolútny prínos, možné nežiaduce účinky, preferencie pacienta a dlhodobú adherenciu.

Kombinovaná hypolipidemická liečba

Ak samotný statín nestačí, odporúčania podporujú eskaláciu liečby. Najčastejším ďalším krokom býva **ezetimib**, ktorý znižuje absorpciu cholesterolu v čreve. Pri veľmi vysokom riziku alebo pri nedosiahnutí cieľov môžu prichádzať do úvahy aj **PCSK9 inhibítory** a ďalšie novšie lieky.

Tento postup je racionálny najmä u pacientov po kardiovaskulárnej príhode, u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou alebo u tých, ktorí napriek maximálne tolerovanej liečbe zostávajú vysoko rizikoví.

Význam režimových opatrení

Farmakoterapia má pevné miesto, ale odporúčania neznižujú význam životného štýlu. Strava, pravidelná fyzická aktivita, kontrola hmotnosti, nefajčenie, liečba hypertenzie a dobrá kompenzácia diabetu ostávajú základom kardiovaskulárnej prevencie.

Režimové opatrenia majú význam nielen pre lipidy, ale aj pre krvný tlak, inzulínovú rezistenciu, zápalový profil a celkové metabolické zdravie. Ich slabinou nie je biologická účinnosť, ale dlhodobá udržateľnosť.

Sledovanie pacienta po začatí liečby

Odporúčania zdôrazňujú potrebu monitorovania účinnosti a bezpečnosti liečby. Po začatí alebo zmene hypolipidemickej liečby má nasledovať kontrola lipidového profilu, aby bolo jasné, či pacient dosahuje očakávanú odpoveď.

Sledovanie nemá slúžiť iba na „naháňanie čísla“. Má pomôcť odhaliť nízku adherenciu, nežiaduce účinky, nesprávne dávkovanie alebo potrebu kombinovanej liečby.

Čo z toho vyplýva pre klinickú prax

Nové odporúčania pre dyslipidémiu 2026 posúvajú klinickú prax smerom k presnejšiemu hodnoteniu rizika, širšiemu používaniu doplnkových lipidových markerov a aktívnejšiemu dosahovaniu cieľových hodnôt LDL cholesterolu.

Najväčší praktický prínos možno zhrnúť takto:

- hodnotiť pacienta komplexne, nie iba podľa LDL cholesterolu,
- uvažovať o Lp(a) aspoň raz v dospelosti, najmä pri podozrení na geneticky zvýšené riziko,
- používať modernú stratifikáciu rizika,
- pri vysokom a veľmi vysokom riziku cielene znižovať LDL cholesterol,
- pri nedostatočnom účinku statínu včas zvážiť kombinovanú liečbu,
- rozhodovať spolu s pacientom, nie iba podľa tabuľky.

Tieto odporúčania sú dôležité, ale netreba ich čítať mechanicky. Najlepšia medicína vzniká tam, kde sa dôkazy, klinický úsudok a hodnoty pacienta stretnú v jednom rozhodnutí.

Prehľadové tabuľky

Tabuľka 1 — Kľúčové lipidové biomarkery a ich klinický význam

Biomarker	Čo meria	Klinický význam	Odporúčanie 2026
LDL cholesterol	Cholesterol viazaný v LDL lipoproteínoch	Silná priama príčinná súvislosť s aterosklerózou a ASCVD	Primárny cieľ liečby vo všetkých rizikových kategóriách
Non-HDL cholesterol	Suma cholesterolu vo všetkých aterogénnych lipoproteínoch (celkový − HDL)	Lepší ukazovateľ rizika pri hypertriglyceridémii, diabete a obezite	Sekundárny cieľ; hodnota = cieľ LDL + 0,8 mmol/l
ApoB	Celkový počet aterogénnych lipoproteínových častíc	Odhaľuje reziduálne riziko aj pri zdanlivo normálnom LDL	Doplnkový ukazovateľ; vhodný pri DM, obezite, metabolickom syndróme
Lipoproteín(a) [Lp(a)]	Geneticky podmienený aterogénny lipoproteín s protrombotickými vlastnosťami	Nezávislý rizikový faktor; nereaguje na statíny ani diétne opatrenia	Meranie aspoň raz v dospelosti; kľúčové pri predčasnom ASCVD v rodine

Biomarker	Čo meria	Klinický význam	Odporúčanie 2026
HDL cholesterol	Lipoproteíny sprostredkujúce reverzný transport cholesterolu	Nízky HDL je ukazovateľom metabolickej dysregulácie a vyššieho KV rizika	Sledovanie; žiaden liek na zvýšenie HDL nepreukázal klinický benefit; cieľom je eliminácia príčin

Tabuľka 2 — Riziková stratifikácia a odporúčaný prístup k liečbe

Riziková kategória	Typický klinický profil	Cieľ LDL	Odporúčaná liečba
Sekundárna prevencia	Prekonaný IM, ICHS, ischemická CMP, PAO, koronárna revaskulácia	Čo najnižší; orientačne **< 1,4–1,8 mmol/l**	Intenzívny statín; pri nedostatočnom efekte kombinácia s ezetimibom alebo PCSK9 inhibítorom
Primárna prevencia — vysoké riziko	Familiárna HCH, DM s poškodením orgánov, CKD s proteinúriou, viacero závažných RF	Znížiť ≥ 50 % alebo orientačne **< 1,8–2,6 mmol/l**	Statín (zvyčajne indikovaný); cieľ určiť individuálne; zvážiť eskaláciu
Primárna prevencia — stredné riziko	10-ročné ASCVD riziko (kalkulátor PREVENT) 7,5–20 %; DM bez komplikácií	Orientačne **< 2,6 mmol/l**	Shared decision making; statín po zvážení očakávaného absolútneho prínosu a preferencií pacienta
Primárna prevencia — nízke riziko	10-ročné ASCVD riziko < 7,5 %; bez závažných rizikových faktorov	Orientačne **< 3,0 mmol/l**	Priorita životného štýlu; farmakoterapia len pri trvale výrazne zvýšenom LDL

** Cieľové hodnoty LDL sú orientačné a vychádzajú z ESC/EAS 2019 a ACC/AHA odporúčaní. Pre presné hodnoty podľa odporúčaní 2026 sa riaďte aktuálnym textom Guideline on the Management of Dyslipidemia.*

Tabuľka 3 — Stupňovitá farmakologická liečba dyslipidémie

Stupeň	Intervencia	Mechanizmus	Pokles LDL	Typická indikácia
1	**Životný štýl** strava, pohyb, hmotnosť, nefajčenie	Zlepšenie metabolizmu, zníženie hepatálnej produkcie VLDL	5–15 %	Základ liečby u všetkých pacientov; súbežne s farmakoterapiou
2	**Statín strednej intenzity** napr. atorvastatín 10–20 mg, rosuvastatín 5–10 mg	Inhibícia HMG-CoA reduktázy → zníženie de novo syntézy cholesterolu	30–49 %	Stredné KV riziko; primárna prevencia u väčšiny pacientov
3	**Statín vysokej intenzity** napr. atorvastatín 40–80 mg, rosuvastatín 20–40 mg	Maximálna inhibícia HMG-CoA reduktázy; zvýšenie LDL receptorov	≥ 50 %	Sekundárna prevencia; veľmi vysoké a vysoké KV riziko
4	**+ Ezetimib** 10 mg/deň	Blokáda NPC1L1 transportéra → inhibícia črevnej absorpcie cholesterolu	Ďalších 15–25 %	Nedostatočný efekt statínu; intolerancia vysokých dávok statínu
5	**+ PCSK9 inhibítor** evolokumab, alirokumab — s.c. každé 2–4 týždne	Inhibícia degradácie LDL receptorov → masívne zvýšenie vychytávania LDL	Ďalších 50–60 %	Veľmi vysoké riziko pri nedostatočnom efekte krokov 1–4; familiárna HCH

Zdroj: 2026 ACC/AHA/AACVPR/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the Management of Dyslipidemia. *Circulation*.
Dostupné na: ahajournals.org

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nove-odporucania-manazment-dyslipidemie-2026-klinicka-prax · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.